ICS 11.020
CCS C 50

DB36

江 西 省 地 方 标 准

DB36/T 2070—2024

疼痛综合评估规范

Specification of comprehensive pain assessment

2024 - 11 - 08 发布 2025 - 05 - 01 实施

江西省市场监督管理局发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　缩略语 1
5　疼痛综合评估基本要求 2
6　疼痛综合评估宣教 2
7　疼痛综合评估方法 2
8　疼痛综合评估相关记录单 3
9　疼痛综合评估流程 4
10 疼痛综合评估质量控制 6
附录 A（资料性）　疼痛评分量表 7
附录 B（资料性）　心理评估量表 10
参考文献 12

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省卫生健康委员会提出。

由江西省卫生健康标准化技术委员会（JX/TC 037）归口。

本文件起草单位：南昌大学第一附属医院、江西省护理学会疼痛护理专业委员会、南昌市第一医院、南昌市洪都中医院、上饶市人民医院、景德镇市第一人民医院。

本文件主要起草人：魏建梅、张达颖、王志剑、刘韦辰、黄霞、王建宁、曹英、刘燕、李春华、陈兰英、蒋治莉、张春华、彭莉贞、汪淑英、解云芳。

疼痛综合评估规范

1 范围

本文件规定了医疗机构不同疼痛类型（急性疼痛、慢性非癌性疼痛、癌性疼痛）的术语和定义、缩略语、评估基本要求、评估宣教、评估方法、评估相关记录单、评估流程、质量控制等内容。

本文件适用于各级、各类医疗机构开展疼痛综合评估工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

T/CNAS01 成人癌性疼痛护理

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

疼痛 pain

一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验，或与此相似的经历。

3.2

疼痛评分量表 pain scale

用来帮助医护人员衡量和量化个体疼痛强度的工具。

3.3

疼痛评估 pain assessment

在疼痛诊疗全过程中，利用一定的方法测定患者的疼痛强度、类型、性质、部位等信息，为临床评判病情、制订治疗方案提供科学依据。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

VAS：视觉模拟评分量表（Visual Analogue Scale）。

NRS：数字评分量表（Numeric Rating Scales）。

VDS：文字描述评分量表（Verbal Descriptor Scale）。

VRS：语言评分量表（Verbal Rating Scale）。

Wong-Baker 面部表情疼痛量表（The Wong-Baker FACES Rating Scale）。
N-PASS：中文版新生儿疼痛、躁动及镇静评估量表（Neonatal Pain，Agitation and Sedation Scale）
FLACC：行为学评估量表（Face, Legs, Activity, Cry, Consolability Observation Tool）。
CPOT：危重症患者疼痛观察工具（Critical care Pain Observation Tool）。
HADS：医院焦虑抑郁量表（Hospital Anxiety and Depression Scale）。

5 疼痛综合评估基本要求

5.1 疼痛综合评估的执行者应掌握相关专业知识及技能。
5.2 疼痛综合评估的原则：相信患者的主诉，常规、全面、量化和动态的评估。
5.3 疼痛综合评估工具的选择:测量疼痛强度的疼痛评分量表及建立含疼痛综合评估的护理记录单等工具。

6 疼痛综合评估宣教

6.1 医护人员应指导患者及家属正确评估疼痛。
6.2 目的及意义：疼痛综合评估是疼痛治疗的基础，准确、及时地评估为临床提供第一手资料，便于在疼痛诊疗过程中根据患者的疼痛状态调整治疗和护理方案，有助于提高镇痛效果。

7 疼痛综合评估方法

7.1 疼痛筛查

医护人员应根据患者在某时间段的主诉进行疼痛筛查，判断有无疼痛。

7.2 疼痛评分量表选择

7.2.1 神志清楚能正常交流的 3 岁以上患儿或成年患者选择 VAS 或 NRS 结合 VDS 与 VRS(参见附录 A.1、A.2、A3、A4）。
7.2.2 神志清楚有先天性认知障碍、语言表达困难的患者（如老年、老年痴呆、聋哑患者）或 3 岁以上不能交流的患儿采用 Wong-Baker 面部表情疼痛量表（参见附录 A.5）。
7.2.3 对 3 岁及以下患儿、意识障碍无法配合完成评估的患者可使用行为学评估量表 FLACC（参见附录 A.6）。
7.2.4 对新生儿疼痛评估可采用中文版新生儿疼痛、躁动及镇静评估量表 N-PASS（参见附录 A.7）。
7.2.5 对使用呼吸机、气管插管、气管切开等机械通气而无法有效沟通的患者可使用危重症患者疼痛观察工具 CPOT（参见附录 A.8）。

7.3 评估内容

7.3.1. 能自我表述疼痛者

7.3.1.1 疼痛综合评估内容：疼痛的部位、性质、发生与持续时间、有无伴随症状、诱发因素/缓解因素和心理、精神状态，运用疼痛评分量表测量疼痛强度。
7.3.1.2 疼痛部位：患者应主诉躯体上疼痛的确切部位，包括牵涉痛、放射痛部位，以及部位不确切的疼痛。

7.3.1.3 疼痛性质：医护人员对疼痛性质进行评估，常见疼痛包括钝痛、隐痛、胀痛、抽搐痛、麻痛、电击样痛、痉挛性痛、绞痛、刀割样痛、针刺痛、烧灼痛、性质不确切的疼痛等。

7.3.1.4 疼痛强度：评估患者某时间段内最痛的分值，根据世界卫生组织将疼痛分为四级三个程度。

——0 级，无痛。

——1 级（1 分-3 分，轻度疼痛），有疼痛，可忍受，生活正常，睡眠不受影响。

——2 级（4 分-6 分，中度疼痛），疼痛明显，影响睡眠，难以入睡，半夜会痛醒。

——3 级（7 分-10 分，重度疼痛），疼痛剧烈，不能忍受，严重影响睡眠，完全无法入睡。

——了解患者疼痛发生与持续时间、有无伴随症状、诱发因素/缓解因素。

7.3.1.5 心理评估：慢性疼痛患者宜采用 HADS 量表评估心理及精神状态（参见附录 B.1）。

7.3.2 无法自我表述疼痛者

运用疼痛评分量表评估疼痛强度，疼痛发生与持续时间、有无伴随症状、诱发因素/缓解因素。

7.4 疼痛综合评估与记录频率

7.4.1 无痛患者或疼痛强度 1-3 分患者：每日应评估记录 1 次，时间宜为 2PM，评估患者前日 2PM－当日 2PM 期间的疼痛情况。

7.4.2 疼痛强度 4-6 分患者：每日应评估记录 3 次，时间宜为 6AM、2PM、10PM，分别评估患者前日 10PM-当日 6AM，当日 6AM-当日 2PM、当日 2PM-当日 10PM 期间的疼痛情况。

7.4.3 疼痛强度≥4 分（CPOT 量表评分≥3 分）、疼痛性质、疼痛部位有变化或有新伴随症状者应通知医生处理。

7.4.4 爆发痛、疼痛强度≥7 分（除产妇外）：遵医嘱静脉或鞘内给药后 15 分钟、皮下注射或肌内注射后 30 分钟、口服给药/直肠给药或非药物干预后 60 分钟应再次疼痛综合评估并记录。

7.4.5 疼痛评分≥4 分患者，出院时进行疼痛评估与记录。

7.4.6 门、急诊患者疼痛综合评估包括以下两种情况：

——医护人员对疼痛患者进行疼痛综合评估并记录；

——门急诊无痛人流、胃肠镜、纤维支气管镜等诊疗操作时，由麻醉医师在麻醉前、麻醉后进行疼痛筛查、评估并记录。

7.4.7 手术患者术后疼痛综合评估（排斥医嘱术后）：

——麻醉苏醒室：术后患者在苏醒室清醒时、出苏醒室前与其它生命体征同步进行疼痛筛查、评估并记录；疼痛强度≥4 分患者，遵医嘱药物干预，30 分钟后再次评估记录；

——术后返回病房时与血压、脉搏、呼吸同时评估一次；手术当日、术后第一天、术后第二天 6AM、2PM、10PM 评估，连续评估 3 天；术后第三天后按术前疼痛综合评估的原则动态评估。

7.4.8 产妇疼痛综合评估（可分为产前、产时、产后三阶段）：

——产前评估：产妇入院后至进产房前由病房护士按外科手术疼痛评估规范评估记录，如建立了分娩记录单则与专科评估项目同步进行疼痛评估记录；

——产时评估：产妇进入产房后与分娩记录单中专科评估项目同步进行疼痛评估记录；

——产后评估：产后即时与分娩记录单中专科评估项目同步进行疼痛评估记录一次，返回病房由病房护士按外科手术后疼痛评估规范评估记录。

8 疼痛综合评估相关记录单

8.1 建立含疼痛综合评估的护理记录单及医疗记录单。

8.2 医护记录的疼痛部位、疼痛性质、疼痛评分量表应保持一致，护理记录的疼痛强度应在医疗疼痛

程度记录范围内。

9 疼痛综合评估流程

9.1 门、急诊患者疼痛综合评估流程

医疗机构门、急诊患者疼痛综合评估应按图1所示的流程进行。

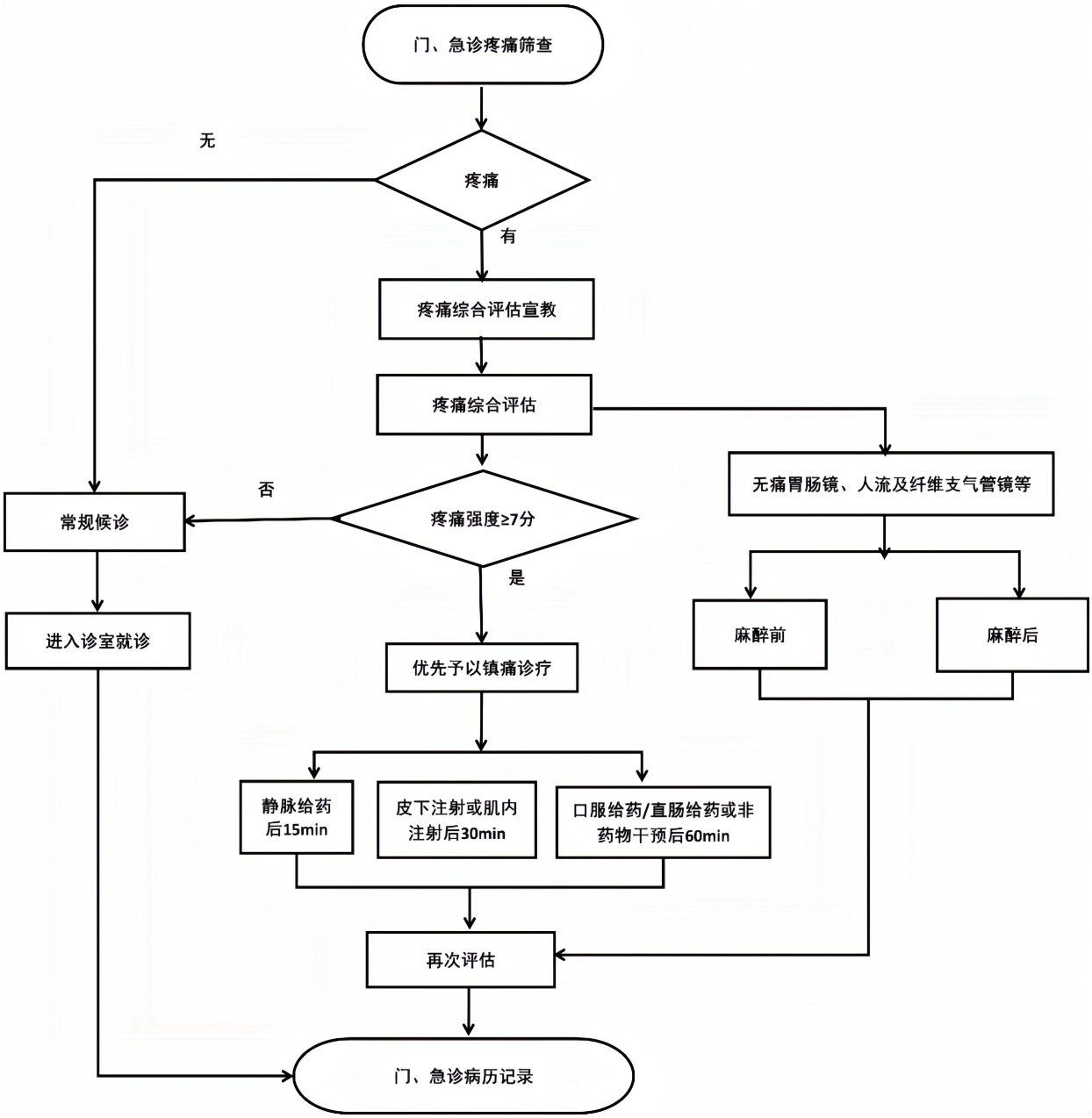


图1 门、急诊患者疼痛综合评估流程图

9.2 住院患者疼痛综合评估流程

9.2.1 急性疼痛

医疗机构住院患者（急性疼痛）疼痛综合评估应按图2所示的流程进行。

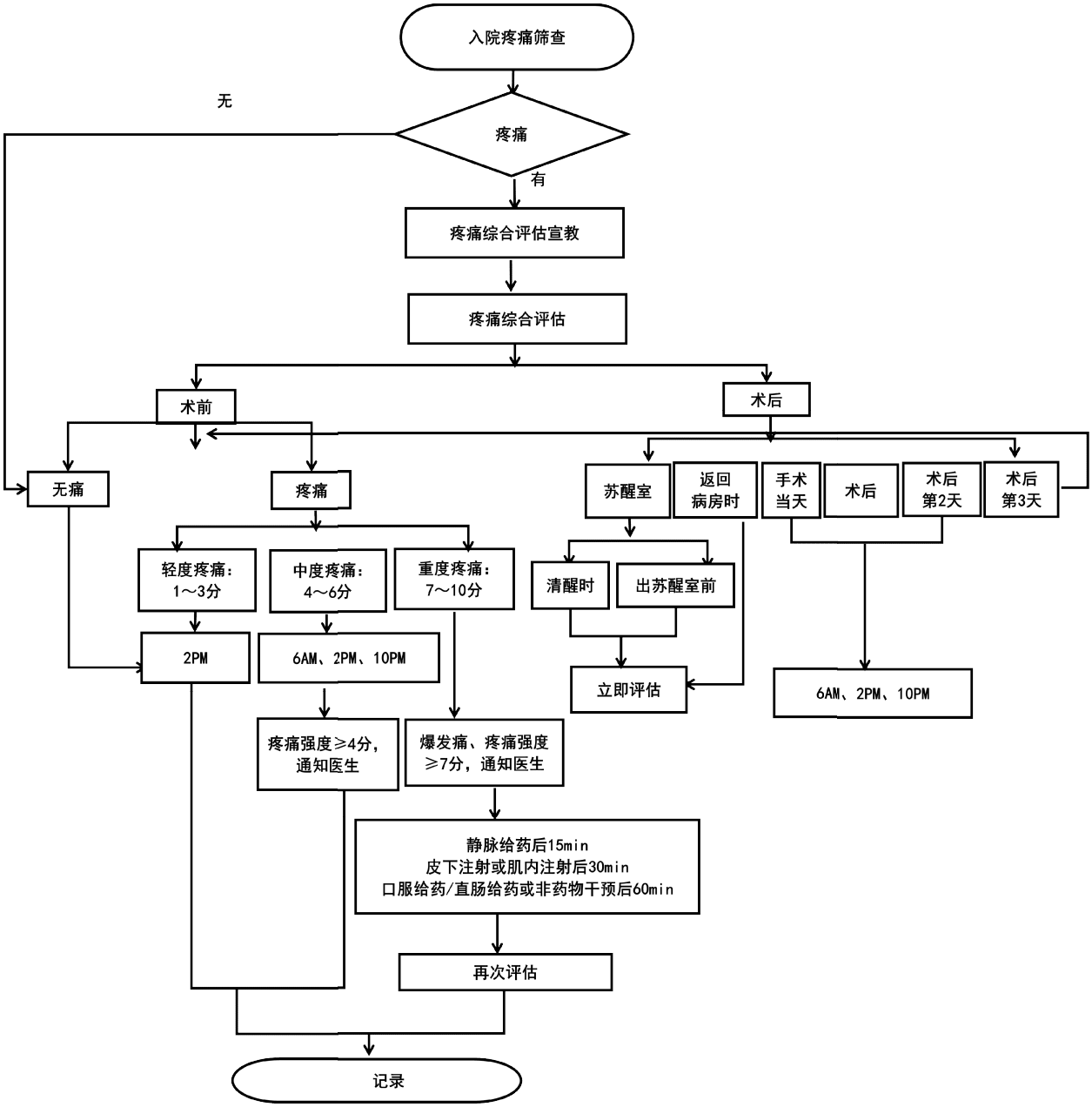


图2 急性疼痛综合评估流程图

9.2.2 慢性疼痛

医疗机构住院患者（慢性疼痛）疼痛综合评估应按图3所示的流程进行。

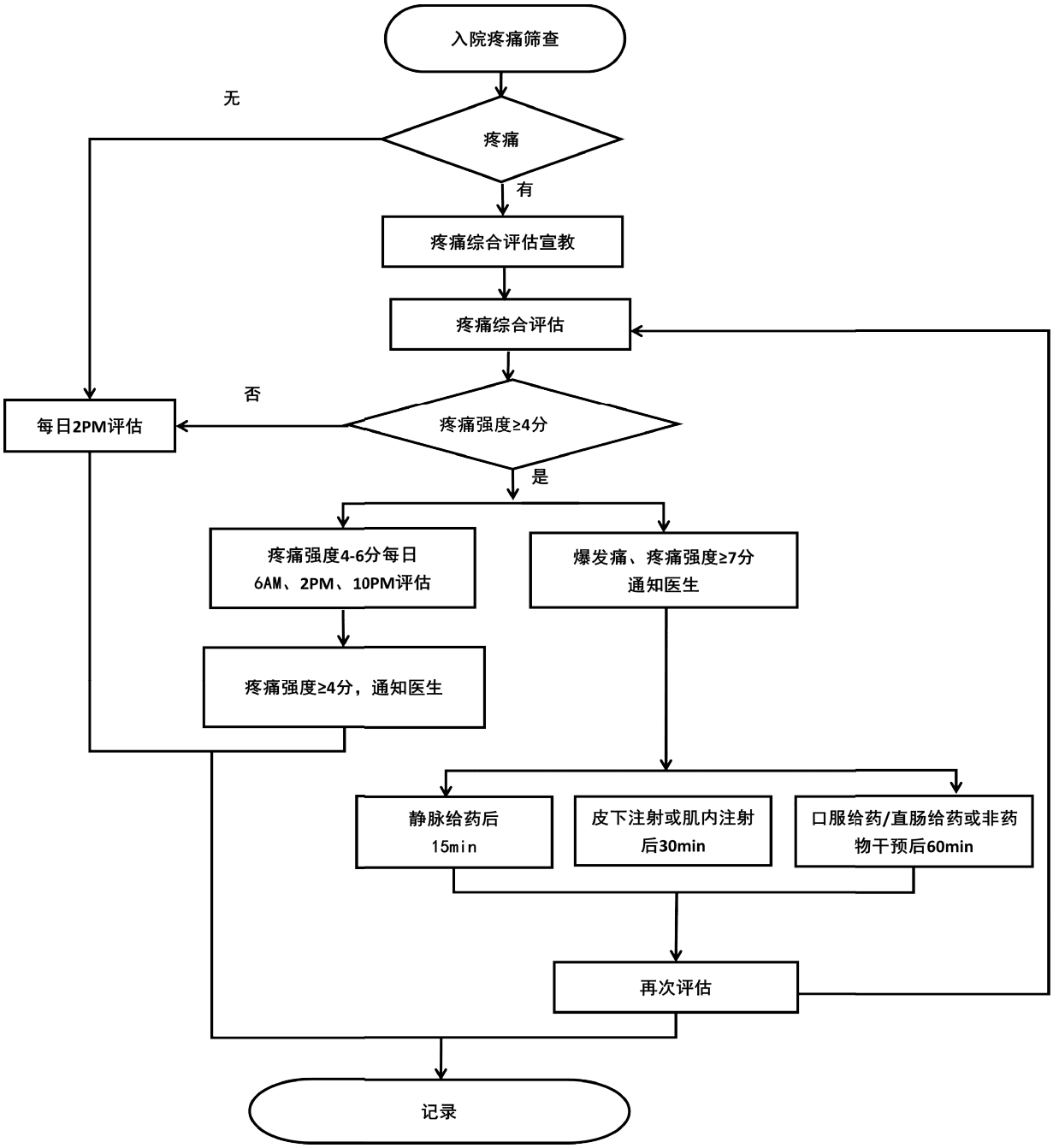


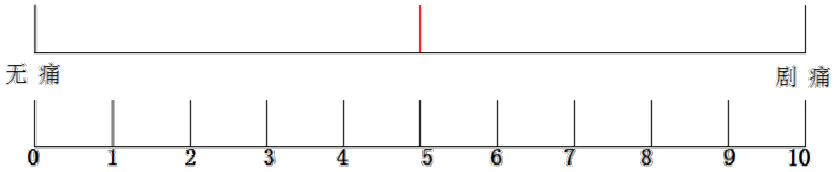
图3 慢性疼痛综合评估流程图

10 疼痛综合评估质量控制

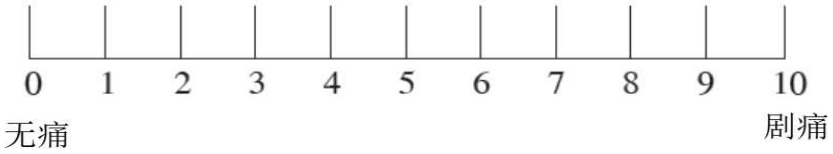
疼痛综合评估质量控制可参照《江西省疼痛护理专业质控评价指标建设项目》中相关要求执行。

附　录　A
（资料性）
疼痛评分量表

表A.1　视觉模拟评分量表

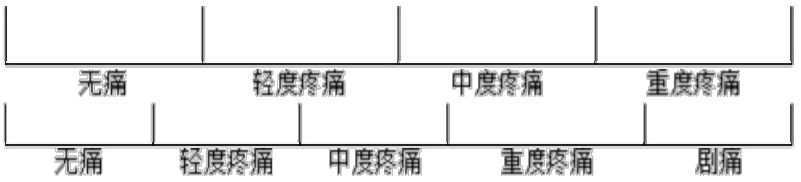


表A.2　数字评分量表

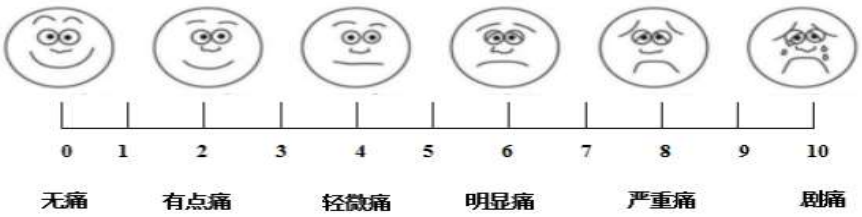


表A.3　文字描述评分量表

表A.4　语言评分量表



表A.5　Wong-Baker 面部表情疼痛量表



表A.6　行为学评估量表

评分法	类别	行为学评分		
		0	1	2
F	脸部表情	平静、微笑，无特殊表情	时有痛苦表情或皱眉、咬牙、下巴有颤动	淡漠、孤僻、不愿交流
L	下肢	正常体位，安静、放松	紧张不安，不停变换体位	踢腿，屈曲双腿，不愿移动，烦躁
A	活动	平卧体位及活动正常	不停扭动，转动	触碰或移动时高声尖叫，睡眠差或不能入睡
C	哭泣	无哭泣	呻吟，偶尔哭泣	持续哭泣，叫喊
C	可安慰性	放松，满足	偶尔抚摸、触碰、拥抱、谈话可使其安静，容易转移注意力	安慰不起作用

表A.7　中文版新生儿疼痛、躁动及镇静评估量表

评估标准	镇静后休息睡眠状态		镇静后休息睡眠状态/疼痛	疼痛/兴奋	
	-2	-1	0/0	1	2
哭吵 易怒兴奋	疼痛刺激后无哭吵	疼痛刺激后有轻微呻吟或哭吵	无镇静/ 无疼痛体征	间歇性激惹或哭吵可安慰	高音调的或不间断的无声哭泣不可安慰
行为状态	任何刺激后均不觉醒 无自主活动	轻微刺激后就可觉醒少许自主活动	无镇静/ 无疼痛体征	烦躁，扭动 频繁觉醒	身体呈弓形，踢腿， 不间断的觉醒或轻微刺激后觉醒/无镇静状态下无动作
面部表情	口唇放松 无特殊面部表情	刺激后有轻微面部表情	无镇静/ 无疼痛体征	间歇的疼痛表现	不断的有疼痛表现
肢体活动 肌胀力	无握持反射 肌肉无力	微弱的握持反射 肌张力下降	无镇静/ 无疼痛体征	手指脚趾间歇性收紧或张开 躯体放松	手指脚趾不断的收紧或张开 躯体紧张
生命体征	刺激后无改变 低通气或呼吸暂停	刺激后有少于基础生命体征 10%的变化	无镇静/ 无疼痛体征	↑基础生命体征的10-20% 刺激后 $SpO_2$76-85%，然后快速恢复正常	↑>基础生命体征的 20% 刺激后 SpO_2≤75%，然后缓慢恢复 呼吸不规则/人机对抗
注：胎龄或纠正胎龄<30 周得分+1。					

表A.8　危重症患者疼痛观察工具

指标	描述	评分	分数
面部表情	未观察到肌肉紧张	自然、放松	0
	表现出皱眉、眉毛放低。眼眶紧绷和提肌收缩	紧张	1
	以上所有面部变化加上眼睑轻度闭合	扮鬼脸	2
肢体运动	不动(并不表示不存在疼痛)无体动	无体动	0
	缓慢谨慎的运动，碰触或抚摸疼痛部位，通过运动寻求关注	保护性体动	1
	拉拽管道，试图坐起来，运动肢体/猛烈摆动，不遵从指令，攻击工作人员，试图从床上爬起来	烦躁不安	2
肌肉紧张	对被动运动不做抵抗	放松	0
	对被动运动做抵抗	紧张和肌肉紧张	1
	对被动运动剧烈抵抗，无法将其完成	非常紧张或僵硬	2
机械通气耐受/拔管后病人的语言发声情况	无警报发生，舒适的接受机械运气	耐受呼吸机或机械通气	0
	警报自幼停止	咳嗽但是耐受	1
	不同步，机械通气阻断，频繁报警	对抗呼吸机	2
	用正常腔调讲话或不发声	正常腔调讲话或不发声	0
	叹息，呻吟	叹息，呻吟	1
	喊叫，哭泣	喊叫，哭泣	2

附　录　B
（资料性）
心理评估量表

表B.1　医院焦虑抑郁量表

请您阅读以下各个项目，在其中最符合你过去一个月的情绪评分上打√。对这些问题的回答不要做过多的考虑，立即做出的回答往往更符合实际情况。

序号	问题	选项	评分
1	我感到紧张（或痛苦）（A）	几乎所有时候	3
		大多数时候	2
		有时候	1
		根本没有	0
2	我对以往感兴趣的事情还是有兴趣(D)	肯定一样	0
		不像以前那样多	1
		只有一点	2
		基本上没有了	3
3	我感到有点害怕，好像预感到什么可怕事情要发生（A）	非常肯定和十分严重	3
		是有，但并不严重	2
		有一点，但并不使我苦恼	1
		根本没有	0
4	我能够哈哈大笑，并看到事物好的一面（D）	我经常这样	0
		现在已经不大这样了	1
		现在肯定是不太多了	2
		根本没有	3
5	我的心中充满烦恼（A）	大多数时间	3
		时常如此	2
		时时，但并不轻松	1
		偶然如此	0
6	我感到愉快（D）	根本没有	3
		并不经常	2
		有时	1
		大多数	0
7	我能够安闲而轻松地坐着（A）	肯定	0
		经常	1
		并不经常	2
		根本没有	3
8	我对自己的仪容失去兴趣（D）	肯定	3
		并不像我应该做的那样关心我	2
		我可能不是非常关心	1
		我仍然像以往一样关心	0

表B.1　医院焦虑抑郁量表（续）

序号	问题	选项	评分
9	我有点坐立不安，好像感到非要活动不可（A）	确实非常多	3
		是不少	2
		并不很多	1
		根本没有	0
10	我对一切都是乐观地向前看（D）	差不多是这样做	0
		并不完全是这样做的	1
		很少这样做	2
		几乎从不这样做	3
11	我突然发现恐慌感（A）	确实很经常	3
		时常	2
		并非经常	1
		根本没有	0
12	我好像感到情绪在渐渐低落（D）	几乎所有时间	3
		很经常	2
		有时	1
		根本没有	0
13	我感到有点害怕，好像某个内脏器官变坏了（A）	根本没有	0
		有时	1
		很经常	2
		非常经常	3
14	我能欣赏一本好书或一项好的广播或电视节目（D）	常常如此	0
		有时	1
		并非经常	2
		很少	3
注：本表包括焦虑和抑郁 2 个亚量表，A 代表焦虑量表，D 代表抑郁量表。每一项均采用 0-3 分的 4 级评分，焦虑和抑郁分量表的分值为：0-7 分属无症状，8-10 分属可疑存在焦虑或抑郁症状，11-21 分属肯定存在焦虑或抑郁症状。			

参 考 文 献

[1]宋学军,樊碧发,万有,等.国际疼痛学会新版疼痛定义修订简析[J].中国疼痛医学杂志,2020,26(09):641-644.

[2]童莺歌,田素明.疼痛护理学[M].浙江大学出版社,2017.

[3]魏建梅,曹英,王志剑,等.疼痛科护理手册[M].清华大学出版社,2019.

[4]魏建梅,王志剑,刘韦辰,等.疼痛评估管理体系的构建及应用[J].中国护理管理,2023,23(10):1447-1451.

[5]万丽,赵晴,陈军,等.疼痛评估量表应用的中国专家共识(2020版)[J].中华疼痛学杂志,2020,16(03): 177-87.

[6]沈巧,郑显兰,史源,等.中国新生儿疼痛管理循证指南（2023年）[J].中国当代儿科杂志,2023,25(02): 109-27.

[7] 江西省疼痛护理专业质控评价指标建设项目(江西省护理学会)